Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
10ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent10vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5049931-19.2023.8.21.0001/RS

AUTOR: AMANDA GARCIA DA SILVA

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

AMANDA GARCIA DA SILVA ingressou com ação ordinária em desfavor de **UNIMED PORTO ALEGRE — COOPERATIVA MÉDICA LTDA**, narrando, em síntese, que possui quadro de saúde sensível desde o nascimento, estando acometida de diversas comorbidades que culminaram no aparecimento de *Alopécia Aerata*, sendo necessário o uso do medicamento *TOFACITINIBE*, que foi o único fármaco que se mostrou eficiente para o tratamento da moléstia. A solicitação de fornecimento do medicamento foi negado pela parte ré, sob o argumento de que o tratamento com o fármaco indicado não está previsto no rol de procedimentos e diretrizes da Resolução Normativa n.° 465/2021 da ANS. Invocou dispositivos legais sobre a matéria e colacionou jurisprudência. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar à parte ré o fornecimento do medicamento *TOFACITINIBE*, na forma prescrita pelo profissional médico. Ao final, pugnou pela procedência da ação para, tornando definitiva a tutela de urgência postulada, reconhecer seu direito ao medicamento prescrito. Postulou a concessão do benefício da gratuidade da justiça e anexou documentos.

Concedida a gratuidade da justiça e indeferida a tutela de urgência postulada (evento 15, DESPADEC1). A parte autora interpôs agravo de instrumento, o qual foi desprovido (processo 5121461-38.2023.8.21.7000/TJRS, evento 20, RELVOTO1).

Citada, a parte ré apresentou contestação (evento 32, CONT1), impugnando, preliminarmente, o valor atribuído à causa. No mérito, defendeu a legitimidade da negativa de cobertura por se tratar de medicamento de uso domiciliar. Invocou o disposto no artigo 17, VI, da Resolução Normativa n.º 465/2021 da ANS. Afirmou que não está obrigada pelo contrato a prestar cobertura assistencial além daquela devidamente pactuada. Ainda, há expressa previsão legal de exclusão de cobertura de medicamentos considerados *off label*. Mencionou dispositivos legais sobre a matéria e colacionou jurisprudência. Ao final, pugnou pelo julgamento de improcedência da ação e anexou documentos.

Sobreveio réplica, ocasião em que a parte autora refutou a tese defensiva, reiterando o pleito de procedência (evento 37, RÉPLICA1).

Rejeitada a impugnação ao valor atribuído à causa (evento 39, DESPADEC1).

Intimadas as partes sobre o interesse na produção de outras provas, nada requereram.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

Não havendo interesse na produção de outras provas, cabível o julgamento antecipado do feito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na ausência de preliminares pendentes de apreciação, passo de imediato ao exame da questão de fundo.

De início, imperativo consignar que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, porque envolvem relação de consumo. Assim dispõe a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*".

No caso, a existência de relação contratual entre as partes, além de incontroversa, está demonstrada pelos documentos anexados aos autos.

Embora o laudo médico anexado pela parte autora descreva, pormenorizadamente, a necessidade de utilização do medicamento *TOFACITINIBE* ao seu tratamento, o contrato de assistência à saúde do qual é beneficiária estabeleceu, expressamente, a exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar. Vejamos:

> **Cláusula 13: Estão expressamente excluídos deste contrato, não gerando direito a qualquer tipo de cobertura, sem prejuízo das limitações previstas nas cláusulas subseqüentes:**
>
> **e) fornecimento de materiais e medicamentos estrangeiros, ou que não estejam nacionalizados, condicionada esta exclusão à existência de similar nacional, bem como de todo e qualquer tipo de medicamento para tratamento domiciliar;**

Acerca dos medicamentos e insumos de uso domiciliar, a Lei n.º 9.656/98 incluiu dentre as coberturas obrigatórias apenas aqueles destinados a tratamento antineoplásico oral (e correlacionados), à medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim, *in verbis:*

> *Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:*
>
> *[...]*
>
> *VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;*

Cabe salientar que o caso não se enquadra nas exceções previstas no artigo 12 da Lei n.º 9.656/98, que assim dispõe:

> *Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:*
>
> *I - quando incluir atendimento ambulatorial:*
>
> *[...]*
>
> *c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;*
>
> *II - quando incluir internação hospitalar:*
>
> *[...]*
>
> *g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;*

Ademais, assim dispôs a Agência Nacional de Saúde Suplementar na Resolução Normativa n.º 465 de 2021:

> *Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.*
>
> *Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:*
>
> *[...]*
>
> *VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;*

De se ressaltar que a orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do STJ que tratam da matéria (RESP n.º 1.692.938 - 3ª Turma e n.º 1.883.654 - 4ª Turma) é no sentido de que os planos de saúde não estão obrigados ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar, como previsto no artigo 10 da Lei n.º 9656/98, exceto os relativos ao tratamento de câncer, que são de fornecimento obrigatório em razão de expressa disposição legal, não sendo essa a hipótese dos autos.

Conclui-se, portanto, que o plano de saúde demandado não está obrigado a fornecer o medicamento postulado.

Esse é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em casos análogos:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA. DEVER DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. **TOFACITINIBE.** TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES. DECISÃO REFORMADA. - Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, deverá ser revogada a tutela de urgência anteriormente deferida à parte agravada, pela ausência dos requisitos supra. - **O fármaco Tofacitinibe 5mg é de uso domiciliar, e portanto não é, a princípio, de fornecimento obrigatório pelos planos de saúde. Ademais, se constata a existência de diversas notas técnicas na plataforma e-NatJus com conclusão desfavorável ao fornecimento da medicação.** - Recurso provido para revogar a tutela de urgência anteriormente deferida. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 52828710820238217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 23-11-2023) - grifei.*
>
> *APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE ALOPÉCIA AREATA. **MEDICAMENTO TOFACITINIBE. USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. NEGATIVA DE COBERTURA QUE NÃO SE MOSTRA ABUSIVA.** 1) Ausente comando, pelo Superior Tribunal de Justiça, que imponha o sobrestamento dos processos que envolvam a discussão versada nos EREsp1.886.929 e EREsp 1.889.704, a preliminar deve ser desacolhida. 2) Tratando-se de contrato regulamentado, devem ser observadas as coberturas mínimas definidas na Resolução Normativa nº 428/2017, atual RN 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS), que apresenta Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, a qual não pode prever aquelas excetuadas no artigo 10 da Lei nº 9.656/98 e, também, não pode excluir ou mitigar as hipóteses do artigo 12 do mesmo diploma legal. 3) É lícito que se excetue o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar - administração em ambiente externo ao de unidade de saúde (não abrangido o home care) -, salvo os antineoplásicos, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, bem como os serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente (Arts. 10, incs. V e VI e 12, da Lei nº 9.656/98). 4) A vedação constante no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998, voltada à operadora de plano*

de saúde, não obsta que, na contratação, atendidos os requisitos regulatórios, as partes incluam dentre as coberturas obrigatórias os medicamentos de uso domiciliar, tendo em vista o princípio da autonomia da vontade, relativo à liberdade contratual. Ademais, é possível a contratação acessória de cobertura de medicamentos domiciliares, de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS. 5) ***Caso dos autos em que o medicamento postulado, "Tofacitinibe 5 mg (Xeljanzt®)", indicado para o tratamento de Alopécia Areata (CID L-63.9) que acomete a autora, é de uso oral e destinado à ministração domiciliar. 6) Considerado que não há no contrato principal previsão acerca da obrigatoriedade de cobertura de medicamentos domiciliares, bem como que não há notícias de contratação acessória, nos termos da RN 310/2012, inexiste qualquer abusividade na negativa de cobertura ofertada pela operadora do plano de saúde.*** *Alteração de posição em atenção aos recentes julgados da Corte Superior (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021). NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível, Nº 50087420520218210010, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 28-07-2022) - grifei.*

Portanto, não vislumbro abusividade na negativa de cobertura feita pela demandada, razão pela qual não prospera o pedido de obrigação de fazer.

Isso posto, julgo **IMPROCEDENTE** o pedido formulado por AMANDA GARCIA DA SILVA em desfavor de UNIMED PORTO ALEGRE — COOPERATIVA MÉDICA LTDA, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte ré, que fixo em 10% sobre o valor da causa, considerando a natureza da causa e o trabalho realizado, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Suspendo, no entanto, a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça concedida à parte autora.

Em caso de interposição de recurso por qualquer dos litigantes, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remeta-se ao Tribunal competente para apreciação.

Na hipótese, se a Serventia observar eventual alegação de preliminar em contrarrazões, deverá ser intimada a parte apelante para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, observado o disposto pelo artigo 1.009, § 2º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE SCHWARTZ MANICA, Juiz de Direito**, em 11/3/2024, às 13:48:1, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10056072906v4** e o código CRC **3b7e212f**.